

Amro 3

Je ne vois pas vos réponses. Alors, je vais avancer sur le cas clinique. Alors, vous voyez sur l'imagerie, on a un poumon qui est distendu avec un élargissement des espaces intercostaux, un aspect fristonné des coupes diaphragmatiques.

D'accord. Et là, il faut également mesurer l'index cardiothoracique. Alors, à quel diagnostic on devrait penser ? Eh bien, c'est un patient qui a un antécédent assez important de tabagisme.

Alors, on pensera éventuellement à une exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive, qui peut être secondaire à une surinfection, à une surinfection branchique due soit à des bactéries, soit à des virus. Soit c'est une exacerbation qui est en rapport avec une bonté du traitement de fond, de la maladie de fond, qui est la BPCO. J'aurai une embolie pulmonaire, un dysfonctionnement ventriculaire gauche.

Alors, quel examen vous allez demander pour affirmer votre hypothèse diagnostique ? Là, je ne vois pas vos réponses, Margu. Est-ce que vous m'entendez, là ? Alors, quel examen vous allez demander sur ce patient ? Je ne comprends pas la question. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une exacerbation d'asthme en post-traumatique ? Je n'ai pas compris la question.

Alors, spirométrie, tout à fait. Quoi d'autre ? Alors, les dédimers pour l'embolie pulmonaire. Il faut toujours essayer d'utiliser un scanner thoracique pour éliminer les points d'urgence devant une présentation aiguë.

Alors, voilà, les dédimers, ils sont à 336 nanogrammes par millilitre. Et comme vous le savez, ils ont une valeur prédictive négative. Les globules blancs, ils sont à la limite normale.

On retrouve qu'il y a comme une lymphopénie. La CRP n'est pas accélérée. Le bilan bactériologique, on a évoqué l'hypothèse infectieuse.

Le CBE montre une flamme polypropylène. Les recherches de BK sont négatives. Il faut aussi réaliser un PCR respiratoire.

Pas uniquement pour le SARS-CoV-2, mais c'est un PCR respiratoire pour identifier l'ensemble des germes ou les virus. Que ce soit des bactéries ou des virus. Alors, bien sûr, il faut faire un bilan de l'authenticisme.

Là, vous l'avez compris. Il faut évaluer tout ce qui est comorbidité, en termes ECG, une échocasse. Là, on voit qu'il y a quand même un état d'hypertension pulmonaire.

Puisqu'on a une pression artérielle pulmonaire. Il est à 77 mmHg. Et bien sûr, la gazométrie.

Vous la voyez. Alors, vous avez la gazométrie réalisée chez ce patient-là. Alors, elle montre un pH.

Un pH 38. Une PACO₂ à 67 mmHg. Et une PAO₂ à 51 mmHg.

Avec une saturation à 83 %. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette gazométrie? Et qu'est-ce que vous préconiserez chez ce patient? C'est tout à fait. Je vais vous le faire quelques mots. Vous voyez qu'il ne parle d'infection linéaire.

On ne peut pas parler d'infection linéaire. Je ne sais pas pourquoi vous parlez. Il faut traiter l'infection linéaire.

Vous pensez à quoi? Je ne comprends plus votre commentaire. Alors, vous voyez que ce patient a une hypoxémie. Une hypercarie.

Et un acidose respiratoire. Donc, vous voyez que son pH, il est bas. Un pH assez tranquille.

C'est tout de la normale. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'acidose respiratoire. Et donc, c'est des personnes, des patients qui nécessiteraient une ventilation.

Et c'est là l'indication de la ventilation non-invasive. Puisqu'on est devant cette insuffisance respiratoire 2. Retenez, c'est une insuffisance respiratoire, vous déchirez l'hypoxémie hypercarie. C'est un patient qui faudra ventiler par la ventilation non-invasive.

Et quand on passe à son contrôle après une séance de VLI, eh bien, vous voyez qu'il y a une amélioration du pH. Il y a une diminution de la pH CO₂. Un début de normalisation.

Pas de normalisation, mais une amélioration de la pH 2. Et bien sûr, c'est une VNI qui va se faire en association avec l'oxygène. Parce que pour ces patients-là qui sont insuffisants respiratoires chroniques, s'ils ne répondent pas très souvent à l'oxygène et qu'il aggrave, parce que même en donnant des débits importants d'oxygène, ça va aggraver leur hypercarie. Et donc, c'est des patients qui nécessitent une ventilation.

Il faudra les ventiler. C'est ce qu'on appelle la ventilation non-invasive. Donc, on retient que c'est une exacerbation aiguë, sévère de bébés seaux secondaires à la non-adaptation thérapeutique et à la poursuite de l'intoxication thravagique.

Alors, quelle serait la conduite ? Voilà, il faut ventiler ces patients-là. C'est une psychothérapie par oral ou injectable pour réduire un peu la réaction inflammatoire. C'est l'immunisation de bétalométhie courte durée d'action, à répéter au cas de besoin.

Et puis, le traitement de faim. Le sevrage pervasif, c'est important. La réhabilitation respiratoire.

La vaccination, c'est important. L'oxygène sévisé préventif. Et puis, c'est un patient, comme ça a été également étiqueté, sur la casométhie.

Il nécessite une oxygénothérapie longue durée. Donc, il faut 16 heures par jour couvrant le

sommeil avec une casométhie de contrôle par la suite. Alors, passons à un autre cas clinique.

C'est un deuxième patient de 37 ans, marié père de deux enfants, résident à Marrakech et immunisé de protection. Il habite dans une maison traditionnelle, mal aérée, un peu humide, avec présence de blague à domicile, absence de plantes ou d'arbres dans l'entourage, absence d'animaux domestiques. Dans ses antécédents, c'est un ancien tabagiste qui a raison de six paquets à nez.

Il se verrait il y a 18 ans, exposé par contre au tabagisme passif. Il a aussi une exposition professionnelle à poussière de bois. Et qui a plus de 10 ans, une limite intermittente légère, non traitée, avec un pyrosis.

Après l'Europa, donc des régularisations acides, pas d'allergie ou d'intolérance médicamenteuse ou alimentaire commune. Et on retrouve dans ses antécédents, un terrain d'atopie familiale, un père asthmatique, une sœur ayant une médecine allergique. Donc, qu'est-ce que vous devriez rechercher à l'interrogatoire ? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre hypoxie et hypoxie ? C'est juste le terme le plus approprié, c'est-à-dire hypoxie.

C'est tout ce que vous parlez de la pression artérielle, de l'oxygène du sang. Alors, chez ce patient-là, qu'est-ce qu'on va rechercher encore une fois au niveau de l'interrogatoire ? Je vous demanderai de participer à ce point-là. On sent le tout.

Quoi d'autre ? C'est tout ? Quoi d'autre ? On sent pas de pression thoracique. Quoi d'autre ? Pourquoi l'expectorations ? Quoi d'autre ? En fait, il ne suffit pas. Les questions les plus pertinentes à poser au niveau de l'interrogatoire, c'est que vous avez plus ou moins une orientation d'un diagnostic, un peu, et vous voulez orienter votre interrogatoire dans ce sens.

Vous n'allez pas demander aux patients, vous avez tout, vous avez expectorations, vous avez douleur thoracique. La majorité des patients qui ont un constructeur pneumologique, ils auront ces signes-là. Maintenant, il faut affiner votre interrogatoire.

C'est-à-dire, il faut déterminer ce qui est caractéristique sémiologique et insupportable. Vous dites aux patients, vous êtes disponible, vous répondez, on le mène. Donc, il faut affiner votre interrogatoire.

C'est comme ça que vous pourriez, par exemple, le caractère saisonnier de la toux ou pas. Est-ce que c'est des signes qui sont perannuels ou pas ? Donc, c'est ça l'intérêt d'affiner l'interrogatoire. Vous n'allez pas vous contenter, vous avez de la toux, vous avez de la dysplie.

Vous n'allez pas être avancé et dire, il y a de la toux, de l'expectorations, de la douleur. Est-ce que vous êtes orienté vers un diagnostic ? Je le vois personnellement, non ? Mais il faut affiner votre interrogatoire en fonction à quoi vous pensez. Autrement dit, déterminer les signes.

Voilà, par exemple, le début de la symptomatologie. Est-ce que c'est une symptomatologie qui a

un début précoce ou qui est une symptomatologie récente ? La toux sèche, est-ce qu'elle a une prédominance nocturne ? Il y a quelques gens qui ont précisé le caractère nocturne. Est-ce qu'il y aurait des facteurs déclans à cette symptomatologie ? Est-ce que c'est une symptomatologie coïncée avec une saison particulière où c'est des symptômes perannuels ? Alors, chez ce patient-là, c'est des symptômes qui sont perannuels.

Et puis, on recherchera les signes fonctionnels associés, les signes généraux. Alors, est-ce qu'il fait de la fièvre ? Est-ce qu'il a un problème de nasale, des détournements ? Interroger sur la sphère ORL. Est-ce que ce sont des symptômes qui retentissent sur l'activité, sur le sommeil ? Est-ce que c'est une notion d'admission aux urgences ? Donc, tout ça, les traitements, est-ce qu'il a reçu des traitements auparavant ou pas ? Est-ce qu'il a fait des explorations fonctionnelles ou pas ? Tout ce qu'il faudra déterminer quand on peut faire un interrogatoire orienté et efficace.

Alors, chez ce patient-là, il avait une saturation correcte avec un mécanisme opéropulmonaire qui était normal et un dédié expiratoire de pointe à 540. Alors, quel diagnostic évoquiez-vous ? Et quel examen complémentaire demandez-vous ? Alors, on passe aux examens complémentaires. Donc, voici la radio-thorax.

On voit bien qu'il y a une distension thoracique. Il n'y a pas de foyer. Et voici l'aspirométrie.

Mon vrai diagnostic, c'est qu'il n'y a pas de foyer. Donc, l'aspirométrie, voilà son résultat interprété. Très bien.

Donc, effectivement, j'ai une bonne réponse ici. C'est un trouble ventilateur. Très bien.

Donc, voici un petit coup qui est bain. Et vous voyez qu'ils sont BMS. Vous comparez.

Et comme je vous ai déjà parlé sur les critères de reproductibilité, on voit bien que c'est un TRE. Alors, qu'est-ce que vous allez demander comme autre bilan ? Alors, quel est le diagnostic que vous allez retenir ? Très bien. Ça plaît probablement vers ANAD.

Alors, quel autre examen complémentaire vous allez demander ? Donc, on a fait le diagnostic positif de l'asthme. Donc, une présentation des antécédents. Compatible.

Il y a un terrain d'asthme. Il y a des sites de rhinites allergiques. On fait l'aspirométrie.

On fait un l'aradretoraxan. C'est partie du bilan initial, comme je vous l'ai déjà dit. Elle n'a pas d'intérêt dans le suivant.

Et on fait l'aspirométrie. Vous avez l'obstruction réversible. Alors, on a un devoir de retenir l'asthme.

Après le diagnostic positif, il y a un bilan étiologique. C'est aussi simple que ça. On va essayer de déterminer qu'il est l'allergène responsable.

Tout à fait un bilan allergologique. Et donc, c'est un bilan qui va comporter des prix de test. Ils étaient réalisés.

Ce sont les tests scrutins. On les appelle tests scrutins. Ils étaient positifs.

Ça, c'est les acariens. Et au BLAD, Germanic. Ce qui explique les acariens comme étant des allergènes.

Des allergènes perannuelles. La symptomatologie sera portée par le patient. Ce sont des symptômes perannuels.

C'est-à-dire qu'ils persistent pendant toute l'année. Contrairement à quoi ? Je vais vous donner un exemple. Contrairement à... Très bien.

Les pollens sont des allergènes saisonnières. Alors, l'énumération était normale. Il n'y avait pas d'éosinophilisme.

Et puis, il faut faire un bilan de comorbidité. C'est un patient qui a... Rappelez-vous, il avait des signes de rhinite. Il faut aussi évaluer.

Je pense que vous l'avez pu voir sur mon RL. Il y a une classification. C'est la classification de l'ARIA.

Ce patient-là, c'est une rhinite intermittente légère. C'est un patient qui rapporte aussi un reflux gastro-œsophagien. Il faut rechercher d'autres comorbidités, à savoir un syndrome d'apnée de sommeil ou un syndrome dépressif.

Donc, c'est un masque qui va être retenu sur les plus pertinentes théorétiques d'un patient âgé de 37 ans à qui il y a eu une exposition au tabagisme passif et dont le bilan allergique a aujourd'hui une sensibilisation aux allergènes DP/DF, leur blague germanique, est un facteur de mauvais contrôle, une rhinite allergique qui n'est pas traitée et un reflux gastro-œsophagien. Donc, si on veut traiter ce patient-là, quel est le but du traitement de ce patient ? Quel est le but du traitement de ce patient ? Éliminer les épisodes. Éliminer les exacerbations.

Quoi d'autre ? Est-ce que tout ce que vous parlez, c'est deux étudiants qui ont répondu ? Si vous voulez mettre un terme un peu plus global, vous dites quoi ? Contrôler la maladie. Quand on parle de contrôle, c'est contrôler les symptômes de journée et de nocturne, c'est éviter les réservations, c'est limiter le recours aux médicaments d'urgence, c'est avoir une fonction respiratoire normale, c'est améliorer la qualité. Alors, chez ce patient-là, comment vous considérez la sévérité de la maladie et quel traitement vous pourriez proposer pour ce patient-là ? On a une réponse sur cette question-là.

Je n'ai pas de réponse. La question, c'est comment vous considérez la sévérité de la maladie ? Pour répondre à cette question, il faut tout simplement qualifier la sévérité selon la classification

d'IGNA que vous avez dans le coup, c'est-à-dire en fonction des symptômes d'urgence, des symptômes nocturnes. Je vous ai présenté la déclaration fonctionnelle.

C'est une activité, le patient rapporte un retentissement sur son activité, sur son sommeil, donc il est considéré comme un anasme au moins persistant et léger. Les moyens thérapeutiques, bien sûr, vous comprenez l'éjection des allergènes identifiées, le traitement de FANS qui devrait être instauré. Alors, vous avez plusieurs propositions.

Le traitement de FANS est le plus utilisé à ce moment-là chez ce patient. Ça va être une association par psychothérapie inhalée faible d'autant. Un bon conduit l'auteur langue de rédaction.

Et en fonction des molécules, il y a certaines qui peuvent être utilisées depuis le matin et le soir. Comme un anasme persistant et léger. On va commencer par des doses, donc on utilise deux fois par jour.

Et un traitement d'urgence à utiliser en 5 minutes. Et puis il faut traiter les facteurs de mauvais contrôle. Il faut traiter l'arymie par la psychothérapie nasale, par les antihistamines.

Il y a un exemple d'antihistamine. Il y a d'autres molécules. Le traitement symptomatique, traiter le reflux de l'asthmosse de plagien par les mesures immunologiques.

Et l'oméprazole. Et le volet préventif. Éviter l'expédition contre la vaginopathie et la vaccination.

La surveillance, bien sûr, elle va se faire après 3 mois. On va encore une fois évaluer le contrôle qui va viser est-ce que la personne observe bien son traitement de fond ou pas. Et on va évaluer les critères de contrôle.

Vous avez le questionnaire. Vous avez déjà ça sur votre cours. Un score.

Il y a des questions qu'on pose aux patients. Et en fonction de la réponse à chaque question, on peut faire la sommation des points et ça vous donne un score final pour, à la fin, voir si votre patient est contrôlé ou pas. Alors, on passe à un autre cas clinique.

C'est une jeune patiente de 27 ans, célibataire, originaire résidente à Marrakech, en son lieu de profession. Et qui présente 20 jours de son admission. Après un épisode de refroidissement, il rapporte une coupe productive, ramenant des effleurations peu lentes sans volonté.

Une dyspnée d'effort stade 5, sans orthopnée. Absence de signes extratoraciques. Et on a un contexte de sensation fébrile et de conservation de l'état général.

L'examen clinique contre une patiente consciente son score de placebo 15, 15ème. Une fréquence respiratoire à 36 par minute. Une fréquence cardiaque à 110 par minute.

Une tension à 11,6. Et une température à 37. Avec une saturation aérobie à 95%.

Passé à 95% sous 3 litres d'oxygène. Présence d'hypocraties digitales et présence de règles crépitantes. Basithoracite bilatérale sèche associée à des renflents et quelques sibilants.

Alors, à quoi vous pensez ? Un noyau à peau. La tension, elle va être correcte. Un courant hyper tendu.

Alors, infection aux oeufs communs. Et le rapport à ce jour de réanimation n'était très loin. Donc, ça n'adhère pas à la définition d'une infusion aux oeufs communs.

Elle paraît dans les 48 heures de son admission. Tumeur excavée. Alors, tumeur excavée, pour une jeune de 27 ans, c'est peu probable.

C'est possible. Mais ce n'est pas fréquent. Puis, la tumeur excavée, ça suppose que la lésion va être latérale, à moins qu'elle n'y ait pas de tumeur ou de tumeur.

C'est aussi extrêmement rare. Alors, pneumonie, on travaille sur une pneumonie bélétrale. On va expliquer les signes physiques retrouvés sur les oeufs communs.

Donc, l'interrogatoire devrait être affiné, encore une fois. Tout se passe au niveau d'interrogatoire. Alors, il faut questionner la personne.

Est-ce qu'elle a eu le couvert culot fin? Est-ce qu'elle a un comptage culot recents? Est-ce qu'elle est exposée au tabagisme facile ou pas? C'est une personne qui rapporte qu'elle est exposée aux déjections de pillons depuis plus de 15 ans. Notion de rapport sexuel à risque. Notion de bronche sans broncorée depuis 5 ans.

Est-ce qu'il y a eu des suivis pour la relâtion de bronche bélétrale depuis plus de 10 ans? Ni sous traitement symptomatique, sans bilan étudiant. Donc, toujours interroger sur est-ce qu'il est porteur de maladies connues? Et, interroger aussi sur le travail, sur les lois dites, etc. Alors, je vous présente Sarah Dioktorax.

Je vous demanderai d'interpréter. Alors, à chaque fois que j'arrive à l'image dite, je n'ai aucun commentaire. Est-ce que vous avez une orientation biologique? C'est pas un aspect de milliard.

Donc, vous avez des opacités micro-reticulées en odulaire qui sont diffuses et bilatérales. Avec des images ariolaires que vous voyez là, qui sont aussi bilatérales, qui correspondraient très probablement à des foyers de délation de bronche. Donc, là on est devant une plombopathie interstitielle diffuse chronique.

C'est une exacerbation aiguë. C'est une plombopathie interstitielle diffuse chroniquement fébrile, parce que la patiente elle rapporte une symptomatologie depuis plus de 5 ans et qui est au stade de chirurgie associée à des foyers de dilatation de blanches. Et comme il y a cette notion d'exposition aux déjections de vivants, elle rapporte aussi une notion de rathoracisme.

Par contre, il n'y a pas de signe de rathoracisme souci. Il n'y a pas de notion de plus d'exclamanteuses et pas de cas similaires dans la famille. Alors, on fait l'enjeu scanner, on pacifie les vaisseaux, il n'y a pas de tremblement, ça élimine l'enjeu pulmonaire.

Et puis là, vous voyez un aspect en vert dépoli, avec des foyers également de fibroses plutôt au niveau des bases et de la partie très loin. On fait une évaluation cardio-vasculaire qui montre une pression, un état d'hypertension pulmonaire. Et le bilan infectieux, il y a le bout blanc qui est à 33 milles, qui est passé à 13 milles, avec l'ICRP qui est à 250, qui est passé à 48.

Bien sûr, c'est une amélioration sous traitement antibiotique. Alors, sujet jeûne, comme je vous l'ai dit, l'hypertépsie, ça peut être une exacerbation aiguë, ça peut être une crise des aigus ou de blé. Et là, il faut éliminer, bien sûr, les causes infectieuses cardio-vasculaires, c'est ce que vous avez dit dans le cours.

C'est pour ça qu'on a fait l'évaluation cardio-vasculaire, ça élimine un problème cardiaque de bouche. Et puis, le bilan infectieux, donc il faut faire un ECG, faire l'infestation respiratoire, l'antigénémie anti-prématoxique, anti-dégenèse a été négative. Une sérologie VIH pour prévenir l'homocysteose, d'autant plus que la patiente qui est là des rapports sexuels à risque.

Et puis, cette atteinte interstitiale, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'exposition de la patiente qui peut avoir une orientation écologique? Oui, il y a une exposition à la vola depuis 15, aux pigeons par contre pendant 15 ans. C'est pour ça que je vous ai dit de faire des clichés en expiration. On voit ici des piégeages AM1 et le diagnostic va être celui d'une alvéolique allergique extrinsèque.

Donc là, on a fait une bronchoscopie qui montrait un LVL infositaire avec des remaniements inflammatoires. Et le dosage de flaciditine d'éjection de pigeons est positif. Donc, on a pu conclure effectivement, ça a permis de confirmer le diagnostic.

Bien sûr, on fait d'autres bilans dans le cadre de l'atteinte interstitiale. Évaluation du retentissement, il faut faire la pléscymographie, mais la patiente n'était pas cohérente. On n'a pas réalisé des preuves correctement.

Comme je vous ai dit, l'évaluation cardio-vasculaire, vous avez une pression artérielle à 60 mmHg. Une gazométrie d'oxygène de la patiente avec une désaturation à l'effort. Et donc, le diagnostic retenu, c'est celui d'une lymphatie d'hypersensibilité dans sa forme chronique fibrosante, qui poumonne des vers d'oiseaux, c'est-à-dire d'assurance respiratoire, retenue devant une symptomatologie compatible.

Un aspect scénographique caractéristique, le dosage de flaciditine était positif. Un lavage d'enveloppes alvéolaires et infositaires et une désaturation à l'effort. Et donc, le traitement va être basé sur une corticothérapie par voie orale à raison de 60 mg par jour, avec traitement adjuvant et oxygénothérapie à domicile, parce qu'il était aussi au stade d'insuffisance respiratoire.

Donc, on passe à un autre cas clinique, celui d'une patiente de 20 ans, femme employée, originaire et résidente à Saphir, en Égypte. Elle n'est pas tabagite, pas d'exposition particulière commune. Ne sont de comptages tuberculeux liés à un nom, un nom qui est traité pour une tuberculose pulmonaire déclarée guérie.

Elle présente depuis 6 mois une installation progressive du stade 2 de sa double associée à une toux sèche nocturne, avec des sensations de fièvre, sueur nocturne et interactions d'état général, faiblesses d'acidémie, amélie et amétrissement non chiffres. Cette patiente avait consulté au niveau de l'hôpital régional de Saphir. Il avait reçu un traitement antivaccinaire, a été démarré, sans confirmation bactériologique.

Et l'évolution a été marquée par l'aggravation de la dyspnée depuis le stade 3, apparition de myalgie au niveau des quatre membres, apparition d'une vérostomie binocondensable et persistance de l'aggravation d'état général. Devant la non amélioration de ce traitement antivaccinaire, la patiente fut adressée dans une formation pour complément de prise en charge. Et à son admission, la patiente était consciente, apéritif, et s'attourait à 91%.

Elle avait une fréquence respiratoire à 22 cycles par minute, hyperhémiconductile, et l'examen corpulmonaire ainsi que le reste de l'examen clinique étaient sans particularité. Voilà, la radiothorax à son admission. Je vous demanderai d'interpréter.

Opacité modulaire. Et puis vous avez aussi l'opacité angulaire. Là, il y avait beaucoup d'attentes.

On a des lésions, traduisons un syndrome interstitiel fait d'opacité modulaire et réticulaire. Et puis, au niveau des bases, comme vous voyez, il y avait des opacités plus larges, plus puissantes, qui sont bilatérales, qui ont tendance à contribuer avec un bon programme aérien. Donc, il y avait une double atteinte alvéolo-interstitielle et cette patiente.

Et là, sur le scanner, on voit effectivement cette atteinte alvéolo-interstitielle. Donc, vous voyez des reticulations et puis des opacités plus confluentes avec un alvéologramme aérien. Donc, on a ici une double compétence d'atteinte alvéolo-interstitielle bilatérale avec rhinopathie médicamenteuse.

On voit bien sur la fenêtre médicamenteuse, au niveau subcarinaire et au niveau médicamenteux antérieur. Donc, quel bilan on va réaliser? On est devant un tableau, finalement, aussi de leopatie interstitielle diffuse avec une atteinte bilatérale confirmée sur le scanner thoracique. On réalise une bronchoscopie, qui permettra d'étudier, il y a déjà l'aspect endoscopique de l'arbre bronchique.

Et là, il avait montré des détecteurs des étrons. Il n'y avait pas besoin ni de granulomes ni de biopsies bronchiques étagées en termes de retrouver un granulome ou des zones granulomateuses en évocatrice par coïdose. L'aspiration pour cito-diagnostic absence de cellulamines et le lavage broncho-alvéolaire est cito-logique plutôt macrophagique.

Donc là, on est plus... Alors, bien sûr, les recherches de Becker ont été aussi demandées, de même que le gène expert dans les expectorations. Ils étaient négatifs. On est donc orienté vers la sarcoïdose.

Quand on est orienté vers la sarcoïdose, on a fait le cours sur ça, il y a tout un bilan à faire. Quand on parle de bilan, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'explorations à réaliser. Un bilan, même s'il est singulier, mais un bilan, c'est un ensemble des chemins qui se font de façon systématique, même devant une sarcoïdose.

Tel que le bilan bactériologique, on va éliminer l'éventuelle tuberculose. Le bilan phosphocalcique, on le fait. La bronchoscopie est faite systématiquement.

Le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui est élevé. On fait un bilan immunologique pour pouvoir éliminer que l'atteinte inter-système est puissante en rapport avec d'autres maladies de système. On fait d'autant plus que la patiente rapporte des arthralgies.

Ça peut être en rapport avec une polyarthritomatoïde. On fait la biopsie des glandes salivaires aussi systématique, rappelez-vous, dans la sarcoïdose. Pourquoi on la réalise ? C'est une biopsie qui n'est pas très invalidante, qui est facile à réaliser, recherchée et atteinte granulomatiquement.

La radio des mains et des pieds, pour avoir cet aspect linéaire, se fait de façon systématique dans la sarcoïdose. De même que les explorations personnelles. Typiquement, on a un trouble ventilatoire restrictif.

Parfois, dans la sarcoïdose, on peut avoir des obstructions. Je vous ai présenté dans le cours les cas où on peut avoir une obstruction associée. Et là, quand on fait la plétismographie, on a une capacité pulmonaire totale qui est élevée avec une hypoxémie aussi enregistrée sur la gazométrie.

L'évaluation cardiovasculaire était sans anomalies. Au total, on a retenu le diagnostic de sarcoïdose médiée au pulmonaire. Résultation de 20 ans.

Révélee par le dispositif STAT3. Mise sous traitement antibacillaire pendant 5 mois, mais sans amélioration clinique ou radiologique. Et la prise en charge, quand on a retenu le diagnostic de service, c'était celui de la sarcoïdose, on a arrêté le traitement antibacillaire et on a démarré la corticothérapie à raison de 40 mg par jour avec des mesures adjuvantes de la corticothérapie, une augmentation de potassium, sauf le calcium qu'on n'ajoute pas dans la sarcoïdose parce qu'on attendait d'avoir une hypercalcémie dans la sarcoïdose.

Avec une bonne évolution clinique, biologique et radiologique de la corticothérapie. Et puis, on l'avait réadressée à des emmettements portants, des substituts, en suivi thérapeutique. Donc la moralité aussi dans cette observation, c'est que quand on veut démarrer un traitement

antibacilaire, il faut absolument avoir une documentation bactériologique, un traitement qui est lourd, qui peut donner des effets secondaires, qui est difficilement gérable.

Quand on démarre un traitement, on démarre un traitement suite à un diagnostic retenu. Parce que des fois, j'entends un traitement antibacilaire de preuve, ça n'existe pas. Il n'y a pas un traitement de preuve.

On traite un diagnostic que nous avons retenu. Alors, on passe à un autre cas clinique. Patient de 36 ans, femme au foyer, régulante à Inns and Out, adressée par son cardiologue qui veut aux urgences pour aggravation de sa dysphonie.

Elle se dit asthmatiquement suivie il y a 6 ans, souvent tolérante seule. Jamais traité pour tuberculose et sans contact tuberculeux. Elle rapporte une rhinite allergique, exposée à la volaille et au bétail.

Maintenant, l'interrogatoire, qu'est-ce que vous allez rechercher ? Ça rappelle un peu le cas que nous avons traité tout à l'heure. L'interrogatoire, on va préciser le début de date, on va recenser les cibles fonctionnelles, respiratoires et extra-respiratoires. On retrouve une notion d'intéressant de l'état général.

L'aggravation s'est faite depuis 15 jours. La dysphonie est devenue statoire. Et à l'également physique, on retrouve une performance status de 1m1, un IMCR 25, une fréquence correcte à 24, il n'y a pas de signal de respiratoire et une saturation à 93%.

Avec à l'examen pléropulmonaire, des râles crépitants vasithoraciques bilatéraux. Voici l'imagerie. On voit ici une atteinte nodulaire, réticulaire, bilatérale et diffuse, définissant un syndrome interstitiel.

Quels seraient les diagnostics à évoquer ? On est devant une pneumopathie interstitielle. On peut penser à une pneumopathie d'hypersensibilité, puisque la personne est en contact avec la volaille. On peut penser à des diagnostics à évoquer devant une atteinte interstitielle.

Une sarcoïdose type 4. Si je vous dis par exemple une sarcoïdose devant une pneumopathie interstitielle, parmi les propositions d'Augustin, une sarcoïdose type 1, est-ce que vous allez cocher ou pas ? Non, très bien. Parce que vous n'avez que l'atteinte bombonnaire et pas une atteinte interstitielle. Quand on dit PIT, ça veut dire qu'on a une atteinte interstitielle.

Si vous évoquez la sarcoïdose, par exemple, soit vous pouvez penser à une atteinte interstitielle isolée sans bombion, ça peut être soit un stade 3, soit un stade d'une atteinte interstitielle avec, si vous avez plus d'éléments tuvaux, ça peut être un stade 4. On peut évoquer une maladie de système, on peut évoquer une vascularie, le syndrome de recherche, il y a aussi ces tempêtes dans l'Asie. Soit, si on n'arrive pas à identifier une cause, on peut évoquer une tuberculose pulmonaire idiopathique. Alors, quel est le bilan ? Bien sûr, dans l'artérite, je vous ai présenté le

scanner angulaire dans l'analyse de la répartition des lésions pulmonaires.

Et là, vous voyez un aspect en mosaïque, les opacités régulières. Là, vous avez des clés en expiration, vous avez ici les lésions noires qui correspondent aux lésions de piégeage, là encore. Sur cette coupe coronale, on voit encore ces lésions de piégeage.

Ça, c'est la coupe intestinale. Donc, le bilan qu'on va demander, alors bien sûr, la bronchoscopie, à la recherche, encore un peu, est-ce qu'il y a des lésions granulomateuses parce que dans la bronchoscopie, on a un granulome. On ne retrouve pas ici pour cette patiente.

Les biopsies comprennent juste un discret remaniement inflammatoire chronique dans ce cas-là. Le lavage bronchoalvéolaire, il montre la présence d'un excrément inflammatoire pour l'immorphe. Donc, on a un peu les mêmes valeurs en termes d'atteintes alvéolaires après une prédominance de l'impressivité.

Le bilan à la recherche de tuberculose est négatif. Le bilan bronchocastrique, pareil. Le bilan biologique, négatif.

Et le dosage de précipites infirmières est positif. Donc, on peut bien sûr tasser le bilan écologique. Après le bilan écologique, on fait un bilan de retentissement.

Et quand on parle de bilan de retentissement, c'est-à-dire qu'on va voir le retentissement de la maladie sur le plan respiratoire et sur le plan cardiovasculaire. Sur le plan respiratoire, on peut réaliser sclerométrie ou clétisthémographie. On peut réaliser autre bilan qui traduit l'atteinte et le retentissement respiratoire.

Alors, si je vous dis quel est le bilan et comment on étudie le retentissement fonctionnel respiratoire, alors la sclerométrie, c'est une bonne réponse. La clétisthémographie, c'est une bonne réponse. Le test de marche de signes, la gazométrie, tout ça, c'est les deux domaines qui nous permettent d'évaluer le retentissement de point de vue fonction respiratoire.

Et puis, à côté de l'évaluation du retentissement respiratoire, on fait le retentissement de la maison, le retentissement cardiovasculaire, qui va se faire par le séjour des professeurs. Et dans ces pathologies respiratoires chroniques, très souvent, on va avoir un retentissement sur le cœur droit, donc on peut avoir des signes d'incidence cardiaque droite clinique. Et on peut également mesurer, comme je vous ai expliqué ça sur le cas d'hypertension pulmonaire, rechercher si il y a une hypertension pulmonaire.

C'est très souvent le cas dans les formes chroniques. Alors ça, c'est le reste du bilan. Dans notre contexte, on fait la sérologie SARS-CoV-2.

Alors, l'écho-cœur, elle montrait les dilatations cardiaques droites avec hypertension pulmonaire. Le test de marche de signes mutants, il y a quand même une désacculation à l'époque. Et la patiente ne fait que 33% de l'athéopergoulie, on va dire 34% de l'athéone.

Donc, il y a quand même un retentissement fonctionnel important. Et sur la gazométrie artérielle, on a une hypoxie. Et à la plexisthémographie, on a un trouble ventilatoire obstructive, moyennement sévère.

Inversible après ventral dilatateur, donc on ne faisait pas ici présenter les résultats. Donc, le traitement pour cette patiente, bien sûr, il faut traiter son âme pour lequel elle est mal soumise. Elle est uniquement mise souvent au lit.

Donc, on majore le traitement de sang. Et on traite des signes de rhinite par la corticothérapie locale, nasale et un antihistamine. Et puis, la pléomépathie hypersensibilité va être, quant à elle, traitée par la corticothérapie.

Cette fois-ci, elle va être administrée par voie orale à la dose de 40 mg par jour associée au traitement adjuvant qui est basé sur la supplémentation en potassium, en calcium et en vitamine. Donc, voilà pour ce cas clinique. Et finalement, on a conclu pour ce cas clinique qu'il s'agit d'une pléomépathie interstitiale non fébrile au stade avec hypertension pulmonaire secondaire à une alvéolite allergique extrinsèque sur une patiente de 36 ans exposée à la volaille et elle a été mise sous corticothérapie orale.

Voilà, je pense qu'on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer quand même de partager avec vous un ensemble de cas cliniques des grandes pathologies que nous avons vues, que ce soit l'asthme, la BTP, les cancers, l'opathie interstitiale. Très bien, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.

Au revoir.